Клинические рекомендации

Наружные отиты

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H60.0** — Абсцесс наружного уха **H60.1** — Целлюлит наружного уха **H60.2** — Злокачественный наружный отит **H60.3** — Другие инфекционные наружные отиты **H60.4** — Холестеатома наружного уха **H60.5** — Острый наружный отит неинфекционный **H60.8** — Другие наружные отиты **H60.9** — Наружный отит неуточненный **H61.0** — Перихондрит наружного уха **H61.8** — Другие уточненные болезни наружного уха **H61.9** — Болезнь наружного уха неуточненная **H62.0** — Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.1** — Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.3** — Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.4** — Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках **H62.8** — Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/663_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Жалобы 4

2.3 Физикальное обследование 4

2.4 Особенности клинических форм 4

3. Диагностика **5**

3.1 Бактериологическое, микологическое и цитологическое исследования 5

3.2 Аудиометрия 5

3.3 Компьютерная и магнитно-резонансная томография 5

3.4 Консультация профильного специалиста 5

3.5 Злокачественный наружный отит 6

4. Лечение 6

4.1 Неосложнённый наружный отит: местное лечение 6

4.2 Системная антибактериальная терапия 7

4.3 Злокачественный наружный отит 7

4.4 Хирургическое лечение 7

4.5 Физиотерапия 8

5. Профилактика. Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Наружный отит является воспалительным поражением ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.
- При неосложнённом наружном отите:
  1. местно ушные капли; при бактериальном отите препараты первого выбора: фторхинолоны;
  2. туалет наружного слухового прохода;
  3. обезболивание.
- При неосложнённом отите системная антибактериальная терапия не показана. Показания к системным антибиотикам:
  1. постлучевой отит;
  2. сахарный диабет;
  3. иммуносупрессия;
  4. хондроперихондрит.
- Эффективность терапии оценивают **через 48–72 часа**. При отсутствии эффекта уточняют диагноз и исключают атопический или контактный дерматит, псориаз, экзему.
- Диагноз злокачественного наружного отита устанавливается только при наличии всех основных критериев (перечень — во вкладке «Диагностика»).

  При злокачественном наружном отите необходимы

  1. определение уровня глюкозы крови;
  2. компьютерная томография (КТ);
  3. госпитализация;
  4. системная антибактериальная терапия **не менее 6 недель**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Наружный отит характеризуется воспалительными изменениями ушной раковины, наружного слухового прохода и эпидермального слоя барабанной перепонки.

Наиболее часто выделяют острую и хроническую (продолжительностью **более 6–12 недель**) формы наружного отита. Разновидность определяется локализацией и характером воспалительного процесса: различают диффузный и ограниченный наружный отит.

Нозологические формы диффузного наружного отита

1. экзема;
2. дерматит;
3. рожистое воспаление;
4. герпес;
5. перихондрит, хондроперихондрит;
6. злокачественный наружный отит и ряд других видов.

Нозологические формы ограниченного наружного отита

1. фурункул;
2. абсцесс.

Развитию воспаления предшествует нарушение целостности кожи, которое могут вызвать:

1. травматическое повреждение;
2. длительное пребывание во влажной среде;
3. изменения кожи на фоне нарушения обмена веществ, сахарного диабета;
4. дерматит или экзематозный процесс.

Предрасполагающие факторы

1. узкий наружный слуховой проход, экзостозы;
2. ношение слухового аппарата;
3. попадание воды в уши;
4. недостаточное образование и изменение состава ушной серы;
5. нарушение местного и общего иммунного статуса;
6. лучевое воздействие.

2.2 Жалобы

Жалобы

1. дискомфорт и боль в ухе, нередко усиливающаяся при надавливании и жевании, с иррадиацией в глаз, зубы, глотку;
2. снижение слуха при полной обтурации слухового прохода;
3. в ряде случаев зуд и выделения из уха.

Системные проявления

1. лихорадка, как правило субфебрильная;
2. ухудшение самочувствия (явления инфекционного токсикоза).

2.3 Физикальное обследование

Признаки при осмотре

1. гиперемия, отёк, инфильтрация и лихенификация кожи наружного слухового прохода, в ряде случаев ушной раковины и поверхностного слоя барабанной перепонки;
2. патологическое отделяемое;
3. при ограниченной форме абсцессы и инфильтраты в наружном слуховом проходе и других отделах наружного уха;
4. регионарный лимфаденит: увеличение, уплотнение, болезненность околоушных, передне- и заднешейных лимфатических узлов.

2.4 Особенности клинических форм

При фурункуле наружного слухового прохода в стадии инфильтрации ведущей жалобой является дискомфорт, усиливающийся при манипуляциях в ухе, в стадии абсцедирования на первый план выходит боль. При диффузном отите беспокоят боль, выделения из уха, возможно снижение слуха.

При экзематозном отите определяются желтовато-розовые очаги с шелушением, беспокоит зуд, в ряде случаев интенсивный и предшествующий высыпаниям. В дальнейшем образуются микровезикулы, эрозии, участки мокнутия, причём элементы разных стадий наблюдаются одновременно.

При герпетическом поражении за 1–2 суток до высыпаний возникают жжение, зуд и покалывание, затем появляются эритема, пузырьки и корочки. Как правило, процесс разрешается за 10–14 дней, а при присоединении вторичной инфекции в течение 3–4 недель.

3. Диагностика

Диагноз устанавливают на основании характерных жалоб и клинической картины; при необходимости его подтверждают лабораторными и другими методами исследования.

3.1 Бактериологическое, микологическое и цитологическое исследования

Выполняют

1. бактериологическое исследование отделяемого;
2. микроскопическое и культуральное исследование на грибы;
3. цитологическое исследование;
4. при подозрении на новообразование: биопсию.

Забор материала

1. до начала противомикробной терапии;
2. под контролем отоскопии;
3. тампоном диаметром до 0,3 см из просвета или со стенок наружного слухового прохода, без контакта с его наружными отделами.

Резистентность возбудителей и возможное наличие грибковой флоры требуют микробиологического исследования с последующим подбором терапии по спектру возбудителей и их чувствительности.

3.2 Аудиометрия

Показания

1. жалобы на снижение слуха после купирования воспаления; цель исследования — исключить острую нейросенсорную тугоухость.

При неосложнённых формах, не распространяющихся на среднее и внутреннее ухо, возможна кондуктивная тугоухость.

3.3 Компьютерная и магнитно-резонансная томография

Показания к КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ)

1. осложнённая форма: формирование костных секвестров, абсцессов.

При неосложнённом отите необходимости в лучевой диагностике нет.

3.4 Консультация профильного специалиста

Показания

1. поражение наружного уха на фоне системного, в том числе инфекционного, заболевания: консультация профильного специалиста и дообследование.

3.5 Злокачественный наружный отит

Диагноз злокачественного наружного отита устанавливается при наличии всех основных критериев.

Основные критерии

1. боль в ухе и головная боль на стороне поражения;
2. отёк стенок наружного слухового прохода;
3. выделения из уха;
4. грануляции в слуховом проходе;
5. микроабсцессы в области уха и основания черепа;
6. очаг воспаления по данным сцинтиграфии;
7. отсутствие эффекта от лечения **более недели**;
8. синегнойная палочка при посеве.

Дополнительные критерии

1. сахарный диабет;
2. поражение черепных нервов;
3. истощение;
4. пожилой возраст.

При невозможности выполнить сцинтиграфию назначают местное лечение **на 1–3 недели**; отсутствие улучшения свидетельствует в пользу злокачественного отита.

При злокачественном наружном отите показано определение уровня глюкозы крови, поскольку в 90–100% случаев он сочетается с сахарным диабетом.

---

4. Лечение

Основа лечения:

1. устранение предрасполагающих факторов;
2. адекватное обезболивание;
3. регулярный туалет наружного слухового прохода.

4.1 Неосложнённый наружный отит: местное лечение

Для местного лечения неосложнённого наружного отита используют препараты, активные в отношении золотистого стафилококка и синегнойной палочки. Эффективность оценивают **через 48–72 часа**. Сохранение симптомов требует уточнения диагноза и исключения атопического или контактного дерматита, псориаза, экземы.

При бактериальном наружном отите препаратами первого выбора являются ушные капли с фторхинолонами.

Ушные капли показаны всем пациентам с бактериальным наружным отитом; препараты перечислены в таблице ниже.

При всех формах наружного отита применяют антисептики и (или) противомикробные препараты:

1. антисептики: бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид, йод с калия йодидом и поливиниловым спиртом;
2. противомикробные препараты: фторхинолоны, аминогликозиды, противогрибковые препараты.

На фоне местного лечения к 7–10-м суткам выздоравливают 65–95% пациентов.

При экзематозной форме применяют кортикостероиды в сочетании с противомикробными средствами.

Ушные капли

Препарат	Состав	Возраст
Офлоксацин	офлоксацин	с 1 года
Ципрофлоксацин + дексаметазон (в КР под названием «Комбинил»)	ципрофлоксацин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	с 18 лет
Норфлоксацин	норфлоксацин	с 15 лет
Рифамицин	рифамицин	без ограничений
Лидокаин + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 1 года
Беклометазон + клотримазол + лидокаин + хлорамфеникол	хлорамфеникол (антибактериальный компонент), клотримазол (противогрибковый компонент), беклометазон (противовоспалительный компонент), лидокаин (местный анестетик)	с 6 лет
Дексаметазон + неомицин + полимиксин B	неомицин + полимиксин B (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений
Фрамицетин + грамицидин + дексаметазон	фрамицетин + грамицидин (антибактериальный компонент), дексаметазон (противовоспалительный компонент)	без ограничений

> В этой рекомендации капли с норфлоксацином разрешены с 15 лет, тогда как в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года. Возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.

4.2 Системная антибактериальная терапия

При неосложнённом наружном отите системная антибактериальная терапия не показана, поскольку её добавление к местному лечению не улучшает результатов.

Показания к системной антибактериальной терапии:

1. постлучевой наружный отит;
2. сахарный диабет;
3. иммуносупрессия.

При хондроперихондрите ушной раковины применяют системные антибиотики и противовоспалительные средства для купирования болевого синдрома и отёка.

4.3 Злокачественный наружный отит

Системная антибактериальная терапия продолжительностью **не менее 6 недель** препаратами с антисинегнойной и антистафилококковой активностью.

4.4 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. фурункул наружного слухового прохода **в стадии абсцедирования**;
2. гнойный хондроперихондрит ушной раковины;
3. пролежень кожи наружного слухового прохода;
4. злокачественный (некротический) наружный отит.

Объём вмешательства

1. ограниченный отит: вскрытие и дренирование абсцессов наружного слухового прохода;
2. злокачественный отит: удаление грануляций, костных и хрящевых секвестров и холестеатомы в пределах зоны поражения.

4.5 Физиотерапия

Для повышения эффективности лечения применяется физиотерапия.

Микробиологическое исследование повторяется до подтверждения элиминации возбудителя.

При сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе необходим контроль уровня глюкозы крови.

---

5. Профилактика. Показания к госпитализации

Профилактика

1. ограничить использование ватных палочек;
2. избегать избыточного туалета наружного слухового прохода;
3. соблюдать гигиену при использовании берушей, слуховых аппаратов и наушников.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. некротический (злокачественный) наружный отит.

Критерии выписки

1. стихание воспалительных явлений в наружном слуховом проходе;
2. отсутствие гнойно-септических осложнений.

Медицинская реабилитация не рекомендована.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Наружные отиты»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее ноября 2027
Код в рубрикаторе	663_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые. Для детей — отдельная КР «Наружный отит» (21_3)

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены с 15 лет, в КР «Отит средний острый» детям старше 1 года.